

Université de Constantine 3 - Faculté de médecine
Centre Hospitalo-universitaire de Constantine Dr Benbadis
Service de Médecine Interne

Sémiologie de l'appareil cutané:

Partie 1

Cours de sémiologie : Etudiants de 3ème année médecine

Enseignante : Dr Kermiche.M

Médecin assistante en médecine interne

Année 2021- 2022 – 2023

Plan du cours :

- I. Introduction*
- II. Rappel anatomique*
- III. Diagnostic en dermatologie*
 - 1. Examen clinique*
 - 2. Examens para-cliniques*
 - I. Différentes anomalies cutanées*
 - 1. Modifications de la teinte des téguments*
 - 2. Lésions cutanées primaires*

Médecin chef de service Chef de département Président du CPRS

Sémiologie de l'appareil cutané

I- Introduction :

- La peau est l'enveloppe du corps humain:
- Un organe immédiatement accessible
- L'examen clinique peut être minutieux et riche de renseignements.
- La sémiologie dermatologique décrit des lésions élémentaires multiples ; et leur connaissance est indispensable pour le diagnostic des dermatoses.
- Une dermatose peut être constituée d'un seul type de lésion élémentaire ou de l'association de plusieurs.
- L'examen histo-pathologique permet une démarche anatomoclinique dans les cas plus difficiles.

II- Rappel anatomique :

La peau est formée de 3 couches:

1.Epiderme:

- fonction de protection contre les agents extérieurs micro-organismes, produits chimiques,... (couche cornée)
- fonction de protection contre la pénétration des rayons UV (mélanine)

2.Le derme: plusieurs fonctions :

- Protection contre les traumatismes,
- Fonction neurologique (terminaisons nerveuses) •
Rôle de réservoir d'eau et d'électrolytes.

3.L'hypoderme: un réservoir de graisses , il joue le rôle d'un isolant thermique.

III- Diagnostic en dermatologie :

La peau est un organe accessible à la vue et au toucher. L'examen clinique en dermatologie devra toujours comprendre :

- Un examen de la peau,
- Un examen des phanères (ongles, poils et cheveux)
- Un examen des muqueuses (buccale, génitale, conjonctivale).

Le diagnostic des affections cutané-muqueuses est établi sur les données de :

- L'interrogatoire,
- L'examen physiques
- Les examens complémentaires

□ Examen clinique :

A/L'interrogatoire:

- Aspect initial : la lésion élémentaire
- Mode de début : localisé/diffus -brutal/progressif •
- Mode d'extension : centrifuge/en plaques...
- Evolution générale :continue /par poussée •
- Signes d'accompagnement :
 - =>Douleur : cuisson, brûlure ou de douleur névralgique...
 - =>Prurit : signe fondamentale : dermatoses prurigineuses (urticaire, eczéma...) et non prurigineuses (psoriasis...)
- Traitements locaux et généraux
- Environnement : Professionnel, social, vestimentaire, cosmétique, sportif,... •
- Antécédents:
 - Personnels : atopie, médicaments (chronologie /éruption+++)
 - Familiaux : atopie, antécédents dermatologiques

B/ L'examen dermatologique :

1- Inspection :

Temps essentiel, elle doit obéir à 4 règles; elle doit être :

- Totale : malade entièrement dévêtu et l'examen de la peau en totalité, mais aussi les ongles, les poils et les cheveux.
- Préparée : après nettoyage de la peau.
- Bien éclairée : à la lumière du jour en s'aidant d'une loupe.
- Minutieuse : elle doit préciser la topographie, la dimension, la teinte, les contours, le relief, le nombre et le mode de groupement des lésions.

Matériel utilisé :



Loupe



Loupe + lampe



Lumière de Wood

2- Palpation : parfois protection (gants)

□ En l'absence de lésion cutanée : systématiquement apprécier : la souplesse, l'élasticité, la température, le degré de sécheresse ou d'humidité, persistance du pli cutané (déshydratation), état du tissu sous-cutané

La palpation se fait avec :

La pulpe et avec la face dorsale des doigts (différences de température); Entre le pouce et l'index (épaisseur et la souplesse de la peau).



- En présence de lésion cutanée : la palpation renseigne :
Induration ou souplesse de la base d'implantation, recherche de l'adhérence aux plans profonds.

L'étirement de la peau entre le pouce et l'index peut remplacer la vitro-pression

3- Vitropression : verre de montre, lame de verre. Elle fait disparaître la congestion vasculaire

4- Friction :

- Dermographisme: urticaire physique ; on trace un motif sur la peau ; le motif apparaît en relief.
- Décollement de la peau après frottement c'est le signe de Nikolsky
- Phénomène de kobner :apparition sur le trajet d' une égratignure de nouveaux éléments d'une dermatose dont le sujet est déjà porteur

5- Curetage : à l'aide d'une spatule en bois ou une curette : squames (dans le psoriasis)



Vitropression

Dermographisme

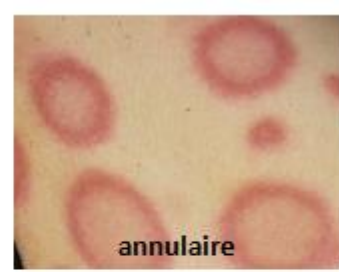
Signe de Nikolsky

Groupement de lésions élémentaires :

Définition: Aspect résultant de la coalescence de plusieurs lésions élémentaires de même nature

Aspects cliniques: -

- en plaque
- linéaire
- annulaire -
- arciforme
- polycyclique -
- en cocarde



▢ Examens para-cliniques :

1- Photographie : accord du malade, utile dans de nombreuses situations - Moyen de surveillance (nævus, angiome)

- But de diagnostic, de suivi thérapeutique ou pour formation médicale

2- Dermatoscopie :

Système d'une ou plusieurs lentilles grossissantes + un système d'éclairage.

Il permet de voir les structures sous-cutanées qui ne sont pas visibles à l'œil nu, ce qui peut aider les cliniciens à déterminer si une lésion cutanée suspecte doit être enlevée ou biopsiée.

3- Prélèvements superficiels à la recherche d'un agent responsable bactérien, parasitaire ou viral.

4- Biopsie cutanée :

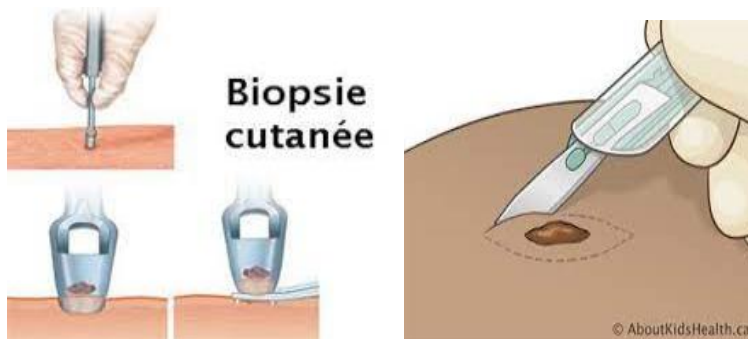
- Un intérêt diagnostic parfois, indication thérapeutique « biopsie exérèse » - Une biopsie doit porter sur une lésion récente, non modifiée

- Le fragment prélevé doit être suffisamment épais pour permettre l'analyse de tous les composants jusqu'au derme profond.

- Certaines lésions, la biopsie à la limite de la peau lésée et de la peau saine. Deux techniques sont possibles : le punch ou le bistouri.

▢ Le punch (lame cylindrique coupante : une "carotte" de peau. Cette technique est souvent pratiquée chez l'enfant car le temps d'intervention est très réduit.

▢ La biopsie au bistouri : plus classique, une suture est ici indispensable



IV- Différentes anomalies cutanées :

▢ 1/ les modifications de la teinte des téguments :

• La pâleur due:

- Soit une vasoconstriction des petits vaisseaux ex la syncope

Soit diminution du nombre de globules rouges au cours de l'anémie

• L'érythème : coloration rouge ; due à une vasodilatation des petits vaisseaux

• L'érythrose : coloration rouge due à une augmentation du nombre de globules rouges

• La cyanose coloration bleutée des téguments et des muqueuses due à une augmentation de l'hémoglobine réduite

- Dyschromie: des variations de la richesse de la peau en pigments
- Hyperchromies :
 - Soit diffuses : mélanodermie un brunissement diffus des téguments (++régions découvertes et régions normalement pigmentées)
 - Soit localisées: taches :Chloasma, ephélides et les naevi
 - Hypochromie : défaut de mélanine ou leucodermie : dépigmentation diffuse :l'albinisme par absence congénitale de pigment
 - dyschromies mixtes : Leuco-mélanodermie : association d'hypochromie et d'hyperchromie mélaniques : vitiligo

▢ Lésions élémentaires dermatologiques :

- Les lésions élémentaires peuvent être : Primitives
: traduisant le processus lésionnel initial,
 - Visibles : Macules
 - Visibles et palpables :
 - Liquidiennes: Vésicules – Bulles - Pustules . •
 - Solides: Papules – Nodules - Végétations
 - Surtout palpables: Nodules – Nouures
- Secondaires : représentant l'évolution de ces lésions primitives

1/ Lésions cutanées primaires :

.1. La macule:

Tache réalisant une modification de la teinte sans modification de l'épaisseur ni de la consistance,

Le diamètre est inférieur à 1 cm.

Elle peut résulter d'une anomalie siégeant dans :

- l'épiderme exemple :vitiligo
- le derme exemple : pétéchie
- l'épiderme et le derme exemple : hyperpigmentation post inflammatoire La macule peut être :

— Erythémateuse : de couleur rouge, s'effaçant à la vitro-pression.

Erytheme actif

Mécanisme: hyperhémie inflammatoire. Différents types (groupement):

- . Morbilliforme . Roséoliforme
- . Scarlatiniforme . Photodistribué



Erytheme passif Mécanisme:

stase sanguine.

Différents types (groupement): .-

deux types :

. Erythro-cyanose .

Livedo

— Purpurique : en rapport avec une extravasation du sang hors des capillaires, de couleur rouge, ne s'effaçant pas à la vitro-pression, punctiforme ou lenticulaire, c'est une pétéchie; elle peut être en stries, ce sont les vibices; ecchymoses , purpura nécrotique

— Vasculaire, c'est la télangiectasie : qui est une ectasie des petits vaisseaux dermiques s'effaçant à la vitro-pression; les angiomes

— Pigmentaire : tache de rousseur, nævus plan.



Purpura pétéchial



Purpura nécrotique



Télangiectasie



Angiome

2. La papule : élévation cutanée, circonscrite de moins de 1 cm de diamètre, solide, due à un infiltrât superficiel, qui guérit sans séquelles

3. La vésicule : est une élévation circonscrite de la peau, de diamètre inférieur à 1 cm, contenant une sérosité.

4. La bulle ou phlyctène : possède les mêmes caractères que la vésicule, elle en est différente par la taille qui est supérieure à 1 cm.

5. La pustule : est semblable à la vésicule et à la bulle, elle n'en diffère que par son contenu purulent.



Papule



Vésicule



Pustule



Bulle ou phlyctène

6. Le nodule : est une masse solide qui siège dans l'hypoderme donc plus profondément que la papule, parfois douloureuse

Nodosité: 0,5 à 1 cm Nodule: > 1cm,

Nouure: > 5cm (forme aiguë) Hypodermite: placard étendu.

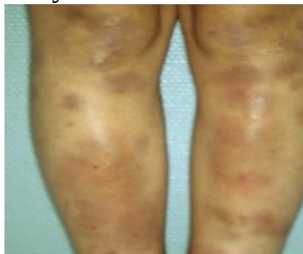
Gomme: évolution secondaire (ramollissement – ulcération) La nouure est l'élément caractéristique de l'érythème noueux.

7. Le kyste : est une cavité remplie de liquide et située dans le derme ou l'hypoderme

8. La tumeur : est une néoformation cutanée de nature et de couleur variable, bénigne ou maligne.

9. Végétations : excroissances d'allure filiforme, digités ou lobulés ramifiés en chou-fleur de consistance molle

Erythème noueux



Gomme



Végétations



